مهارت‌های ارتباطی

دکتر وحیدرضا نورآبادی

متخصص اعصاب و روان
(روانپزشک)

ارتباط مؤثر چیست؟

ارتباط، فرآیند انتقال پیام از فرستنده به گیرنده است، مشروط بر اینکه محتوا به‌درستی منتقل و درک شود.

در مدل‌های جدید، به‌جای (فرستنده و گیرنده) از (برقرارکنندگان ارتباط) استفاده می‌شود، زیرا هر دو طرف هم‌زمان هم فرستنده‌اند و هم گیرنده.

ارتباط کادر درمان و بیمار از نوع (یاری‌دهنده) است :هدف‌دار، حرفه‌ای و مبتنی بر احترام متقابل —برخلاف ارتباط روزمره.

سه لایه هر پیام

کلامی

محتوای گفتاری؛ کلمات و جملات انتخاب‌شده

فراکلامی

لحن، سرعت، شدت و آهنگ صدا

غیرکلامی

زبان بدن، حالت چهره، فاصله فیزیکی

عناصر هفت‌گانه فرآیند ارتباط

1 برقرارکنندگان ارتباط

هر دو طرف هم‌زمان پیام می‌فرستند و دریافت می‌کنند

2 پیام

محتوای اصلی ارتباط : گفتار، نوشتار، رفتار یا حتی سکوت

3 رسانه (Channel)

شیوه انتقال پیام : زبان گفتاری، نوشتاری، اشارات

4 کانال (Medium)

واسطه انتقال که از طریق حواس عمل می‌کند

5 نویز (Noise)

مزاحمت فیزیکی یا استنباطی که پیام را تحریف می‌کند

6 بازخورد (Feedback)

پاسخی که نشان می‌دهد پیام تا چه حد درک شده است

7 بافت (Context)

محیط فیزیکی، زمانی، فرهنگی و اجتماعی ارتباط

سطوح سه‌گانه ارتباط

1

درونی (با خود)

گفت‌وگوی درونی با خود. افکار مثبت، اعتمادبه‌نفس و خودآگاهی هیجانی، پایه ارتباط مؤثر با دیگران است.

2

بین‌فردی

ارتباط رودرو با بیمار، خانواده و همکاران .مهم‌ترین و پرکاربردترین سطح؛ شامل همدلی، پرسشگری و گوش‌دادن فعال.

3

عمومی

ارتباط با گروه‌های بزرگ‌تر (سخنرانی بهداشتی، آموزش همگانی)؛ نیازمند تطبیق لحن، زبان بدن و ابزارهای رسانه‌ای.

چرا مهارت ارتباطی در بیمارستان حیاتی است؟

1 کاهش خطای پزشکی

انتقال ناقص یا مبهم اطلاعات، از علل شایع خطاهای بالینی است

2 افزایش رضایت بیمار

ارتباط همدلانه، اعتماد و رضایت بیمار را افزایش می‌دهد

3 کاهش تعارض و شکایت

سوءتفاهم ارتباطی، منبع اصلی شکایات بیمارستانی است

4 هماهنگی تیمی

انتقال دقیق اطلاعات میان شیفت‌ها و بخش‌های مختلف

5 پایبندی درمانی

توضیح روشن، همکاری بیمار با درمان را افزایش می‌دهد

6 کاهش فرسودگی شغلی

ارتباط سالم تیمی، استرس شغلی کارکنان را کاهش می‌دهد

ارتباط کلامی مؤثر :نکات کلیدی

1. **واژگان ساده و قابل‌فهم**
   پرهیز از اصطلاحات پیچیده پزشکی که برای بیمار نامفهوم است

2. **تن صدای مناسب**
   نه خیلی بلند و نه خیلی آرام؛ متناسب با موقعیت و محتوا

3. **پرهیز از جملات کلیشه‌ای**
   دوری از عبارات تکراری و قضاوت‌آمیز که همدلی را کم‌رنگ می‌کند

4. **انعطاف‌پذیری و زمان‌سنجی**
   توجه به زمان مناسب برای صحبت و انعطاف در گفت‌وگو

یافته پژوهشی

سهم هر کانال در انتقال پیام‌های احساسی

۷٪

کلمات

۳۸٪

لحن صدا

۵۵٪

زبان بدن

طبق پژوهش‌ها، در پیام‌های احساسی که میان کلام و لحن/زبان بدن ناهماهنگی وجود دارد، مخاطب عمدتاً به لحن صدا و زبان بدن اعتماد می‌کند، نه کلمات .۵۵٪ از تأثیر ارتباط، غیرکلامی است.

زبان بدن —بخش اول

ارتباط غیرکلامی : فضا، بدن، چهره و نگاه

1 فضا و قلمرو (Proxemics)

فاصله فیزیکی مناسب با بیمار : ۴۵تا ۷۵سانتی‌متر برای گفت‌وگوی صمیمی، ۱٫۵تا ۳٫۵متر برای تعامل اجتماعی

2 حالت بدن (Posture)

نشستن روبروی بیمار در سطح چشم، نشان‌دهنده احترام است؛ ایستادن بالای سر بیمار، حس قدرت و تهدید ایجاد می‌کند

3 حالت چهره

حالت چهره ابراز شادی، غم، ترس یا خشم را نشان می‌دهد؛ کادر درمان باید چهره خود را کنترل کند تا احساسات منفی را منتقل نکند

4 تماس چشمی

نگاه مستقیم و مؤدبانه نشان توجه است؛ در برخی فرهنگ‌ها تماس طولانی چشمی بی‌احترامی محسوب می‌شود

زبان بدن —بخش دوم

ارتباط غیرکلامی :حرکات، لمس و سکوت

حرکات دست و سر

- تکان سر : تأیید و همراهی
- مشت گره‌کرده : نشانه عصبانیت
- دست‌های باز و آرام : نشانه آرامش

لمس (Touch)

- از مؤثرترین راه‌های ابراز همدلی و امنیت
- باید با احتیاط انجام شود
- همیشه با اجازه بیمار

سکوت

- سکوت فعال، فضایی برای تفکر می‌سازد
- بیان احساسات عمیق بیمار را تسهیل می‌کند
- نشانه احترام و صبر است

مهارت بنیادین

گوش‌دادن فعال (Active Listening)

1. **با تمام وجود گوش دهید**
   نه برای پاسخ‌دادن، بلکه برای درک؛ روبروی بیمار بنشینید
2. **تماس چشمی و تکان سر**
   برای نشان‌دادن توجه خود در طول گفت‌وگو استفاده کنید
3. **حواس‌پرتی را حذف کنید**
   به ساعت نگاه نکنید و مشغول کار دیگری نباشید
4. **پرهیز از قطع صحبت**
   اجازه دهید بیمار جمله خود را کامل کند

ابزارهای عملی

تکنیک‌های بیان مؤثر در گفت‌وگوی بالینی

1 بازتاب احساسات

احساس پنهان بیمار را کشف و بیان کنید :به‌نظر می‌رسد از این تشخیص نگران شده‌اید

2 پرسش‌های باز

به‌جای بله/خیر، بپرسید: چه احساسی دارید؟ یا لطفاً بیشتر توضیح دهید

3 خلاصه‌سازی

گفته‌های بیمار را خلاصه و کلمات کلیدی را تکرار کنید تا احساس درک‌شدن کند

4 پرهیز از نصیحت و قضاوت

از نصیحت بی‌جا، تحقیر، طرد و تغییر ناگهانی موضوع بپرهیزید

موانع ارتباطی رایج و راه رفع آن‌ها

1. **پیش‌داوری و برچسب‌زدن**
   بیمار را بر اساس ظاهر یا سابقه پزشکی‌اش قضاوت نکنید
2. **پاسخ‌های کلیشه‌ای**
   از جملات قالبی مثل همه چیز درست می‌شود بپرهیزید
3. **ارتباط تدافعی و خصمانه**
   احساس بیمار را بپذیرید :حق دارید عصبانی باشید؛ بیایید راهی پیدا کنیم
4. **تحمیل ارزش‌ها**
   عقاید شخصی خود را به بیمار تحمیل نکنید
5. **گوش‌ندادن بی‌توجه**
   هنگام صحبت بیمار، به ساعت نگاه نکنید یا مشغول کار دیگر نباشید

ارتباط با گروه‌های خاص بیماران



بیماران کم‌شنوا

روبروی آن‌ها بنشینید، آرام و شمرده صحبت کنید، از زبان اشاره یا نوشتن کمک بگیرید



بیماران کم‌بینا

خود را معرفی کنید، قبل از لمس اجازه بگیرید، با صدای معمولی صحبت کنید



ناتوانی شناختی

جملات کوتاه و ساده، پرهیز از سؤال باز، کمک از تصاویر و اشیاء، صبوری



بیماران بیهوش

فرض کنید صدای شما را می‌شنوند؛ پیش از هر اقدام با او صحبت کنید



غیرفارسی‌زبان

از مترجم یا واژه‌نامه استفاده کنید و از زبان بدن و پانتومیم کمک بگیرید

سه مرحله ارتباط یاری‌دهنده کادر درمان و بیمار



1آشنایی

معرفی، ایجاد اعتماد و فضای امن



2اجرا

قرارداد درمانی و ارائه مراقبت



3پایان

اختتام رابطه و انتقال اطلاعات

مرحله ۱ از ۳

آشنایی :معرفی و ایجاد اعتماد



1. کادر درمان خود را با نام و سمت معرفی می‌کند
2. با احترام، لبخند و رفتار مؤدبانه، فضای امنی برای بیمار ایجاد می‌کند
3. اطلاعات اولیه را از پرونده یا گزارش قبلی به‌دست می‌آورد
4. انتظارات متقابل را مشخص می‌کند

اجرا :ادامه ارتباط و قرارداد درمانی



طولانی‌ترین مرحله؛ شامل جمع‌آوری اطلاعات، تشخیص کادر درمانی، برنامه‌ریزی و اجرای مراقبت .
کادر درمان به‌عنوان معلم، مشاور و حامی بیمار عمل می‌کند.

قرارداد درمانی : توافق بر سر نقش‌ها، اهداف، زمان‌بندی و پاداش‌های رفتاری

- واقع‌بینانه
- قابل‌اندازه‌گیری
- مثبت
- زمان‌بندی‌شده
- قابل‌ارزیابی

پایان :اختتام ارتباط



1. زمانی رخ می‌دهد که اهداف درمانی محقق شوند یا بیمار ترخیص شود
2. کادر درمان باید احساسات بیمار درباره پایان ارتباط (نگرانی، اضطراب، دلتنگی) را بپذیرد
3. بیمار را برای ادامه مسیر آماده می‌کند
4. انتقال اطلاعات به کادر درمان بعدی یا مرکز دیگر، بخش مهمی از این مرحله است

ارتباط بین‌حرفه‌ای

ارتباط کادر درمان با سایر اعضای تیم بهداشتی



کادر درمان به‌ندرت تنها کار می‌کنند و نیاز به ارتباط مؤثر با پزشکان، سرپرست کادر درمان، سایر کادر درمان و کارکنان پشتیبان دارند.

گزارش شفاهی شیفت

به‌صورت رودررو و با ذکر نکات کلیدی

پرونده بیمار

مستندسازی کتبی دقیق از وضعیت، اقدامات و پاسخ بیمار

کنفرانس‌های تیمی

بحث و تبادل‌نظر برای بهبود مراقبت

ارجاع بیمار

ارائه اطلاعات کامل هنگام ارجاع به سایر بخش‌ها یا مراکز

کاربرد بالینی

گفت‌وگو با بیمار یا همراه دشوار

1

حفظ آرامش خود

پیش از پاسخ، چند ثانیه تنفس آگاهانه و حفظ خونسردی

2

پذیرش احساس، نه دفاع

حق دارید عصبانی باشید؛ بیایید راهی پیدا کنیم

3

بیان ساده و شفاف

پرهیز از اصطلاحات تخصصی نامفهوم برای غیرمتخصص

4

گوش‌دادن بدون قضاوت

اجازه دادن به فرد برای بیان کامل نگرانی خود

5

ارائه گزینه و راه‌حل

تمرکز بر آنچه می‌توان انجام داد، نه محدودیت‌ها

6

درخواست حمایت تیمی

در صورت نیاز، مشارکت‌دادن سرپرست کادر درمان یا مسئول بخش

بُعد انسانی ارتباط

ارتباط با خود : بنیاد همه ارتباطات

ارتباط با خود، مهم‌ترین و گمشده‌ترین بخش مهارت‌های ارتباطی است .
کادر درمان باید از افکار، احساسات و خستگی عاطفی خود آگاه باشد.

گفت‌وگوی درونی مثبت

نه سرزنش‌گر — به کادر درمان کمک می‌کند تا در شرایط بحرانی، آرامش خود را حفظ کند

مرز بین (من حرفه‌ای) و (من شخصی)

همدلی نامحدود بدون مرزبندی، به (خستگی همدلی) و فرسودگی شغلی منجر می‌شود

با تشکر از توجه شما